

A-propos de l'hydatidose :

- A. L'hôte intermédiaire est le chien
- B. Contient à l'intérieur un embryophore.
- C. correspond chez l'homme à une impasse parasitaire.
- D. L'hôte définitif peut-être un bovin, un mouton ou un dromadaire
- E. est lié à la présence dans l'organisme de larves d'Echinococcus granulosus

Les facteurs d'hyper-endémicité de l'hydatidose en Tunisie sont:

- A. L'intensité d'élevage en milieu rural tunisien qui reste largement traditionnel
- B. La densité du réservoir canin
- C. le ramassage systématique des carcasses des ruminants décédés
- D. L'abattage non contrôlé surtout en zone rurale
- E. Le climat tempéré de la Tunisie, assez humide dans les zones d'élevage du Nord et du Centre.

Le diagnostic biologique présomptif d'une infection chronique à Echinococcus granulosus est réalisé sur :

- A. Une hyperéosinophilie.
- B. La présence d'anneaux mobiles d'Echinococcus granulosus sur les selles ou dans les sous-vêtements du patient.
- C. Un test anal à la cellophane adhésive afin de rechercher des œufs d'Echinococcus chez le patient.
- D. Un examen immunologique à la recherche d'anticorps sériques anti-E. granulosus.
- E. Une lymphopénie.

Parmi les circonstances de découverte suivantes quelles sont celles qui sont justes ?

- A. Une symptomatologie frustrée à type de dyspepsie
- B. La découverte d'une masse de l'hypochondre gauche
- C. Une complication du KHF
- D. La découverte peut être fortuite E. La découverte peut être systématique

A la radiographie d'abdomen sans préparation debout et à la radiographie thoracique de face et de profil on peut retrouver en cas de KHF non compliqué

- A. A. Un pneumopéritoine
- B. Une calcification en boule de billard en regard de l'aire hépatique
- C. Une image en brioche ou en soleil levant de projection postérieure sur la Rx thorax de profil

- D. *Une surélévation de la coupole diaphragmatique gauche*
- E. *Un niveau hydro-aérique sous phrénique droit*

En imagerie, le kyste hydatique hépatique type IV :

- A. *pose un problème de diagnostic différentiel avec les tumeurs hépatiques*
- B. *possède une paroi partiellement calcifiée*
- C. *s'accompagne d'une aérobie*
- D. *peut s'associer à d'autres localisations intra hépatiques*
- E. *se complique d'une thrombose porte*

Parmi les mesures prophylactiques du KHF on retient:

- A. *Éducation sanitaire de masse*
- B. *Lutter contre les abattages clandestins*
- C. *Se laver les mains après avoir caressé un chien*
- D. *Bien laver les crudités*
- E. *La lutte contre les piqûres de phlébotomes*

On peut observer une aérobie :

- A - *Dans le kyste hydatique du foie rompu dans les voies biliaires*
- B - *En cas d'abcès amibien du foie*
- C - *Lors d'un iléus biliaire*
- D - *Après anastomose bilio-digestive*
- E - *Après sphinctérotomie oddienne*

La découverte échographique d'un kyste biliaire :

- A. *nécessite un complément d'exploration par IRM*
- B. *pose un problème de diagnostic différentiel avec le kyste hydatique type I*
- C. *est le plus souvent fortuite*
- D. *nécessite une ponction écho-guidée pour confirmer le diagnostic*
- E. *doit être complétée par un bilan hépatique*

La vomique hydatique témoigne de l'ouverture d'un kyste hydatique du foie dans

- A. – L'estomac
- B. – Le duodénum
- C. – La cavité pleurale
- D. – Les voies biliaires
- E. – Les bronches

La complication la plus fréquente d'un kyste hydatique du foie est :

- A. – L'ouverture dans le thorax
- B. – L'infection
- C. – L'ouverture dans les voies biliaires
- D. – La rupture dans le péritoine
- E. – La compression vasculaire

L'infestation de l'homme par l'*Ecchinococcus granulosus* peut se faire par :

- A – Ingestion de viscères de mouton contenant le parasite
- B – Contact direct avec un chien porteur du parasite
- C – Ingestion d'aliments souillés par les embryophores
- D – Contact direct avec un mouton porteur du parasite
- E – Ingestion d'aliments souillés par la larve hydatique

Les kystes hydatiques du dôme hépatique peuvent se compliquer :

- A. – D'ouverture dans le thorax
- B. – D'ouverture dans les voies biliaires
- C. – D'ouverture dans le péritoine
- D. – De compression de la voie biliaire principale
- E. – De compression du confluent cavo-sus-hépatique

Dans une angiocholite aigue, quels sont parmi les signes suivants, ceux qui constituent des signes de gravité ?

- A – troubles neurologiques
- B – Insuffisance rénale aigue

- C – Hyperbilirubinémie
- D – Insuffisance hépato-cellulaire
- E - Hyperamylasémie

L'étiologie d'une angiocholite aiguë peut être :

- A – Une lithiase de la voie biliaire principale
- B – Une tumeur hépatique
- C – Un kyste hydatique du foie
- D – Un ampullome vaterien
- E – Une lithiase intra-hépatique

La rupture d'un kyste hydatique du foie dans les voies biliaires est suspectée à l'échographie devant:

- A/ La visualisation d'une fistule kysto-biliaire
- B/ La dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et de la voie biliaire principale
- C/ L'existence d'images échogènes dans la voie biliaire principale
- D/ L'existence d'une aérobilie
- E/ Un kyste de type III

Le scanner est particulièrement indiqué dans le kyste hydatique du foie

- A/ Kyste unique type IV à l'échographie
- B/ Suspicion de récurrence hydatique
- C/ Kystes hydatiques multiples
- D/ Kyste unique type III à l'échographie
- E/ kyste hydatique ouvert dans le thorax

La rupture du kyste hydatique dans le péritoine est suspectée devant :

- A. – Un urticaire
- B. – Un état de choc
- C. – Une angiocholite aiguë
- D. – Une vomique hydatique
- E. – Une défense abdominale généralisée

Quelles sont les propositions fausses :

- A. La localisation au niveau du foie droit est plus fréquente qu'à gauche.
- B. La taille du kyste dépasse exceptionnellement 5 cm
- C. La membrane prolifère permet la nutrition du kyste par imbibition
- D. Le sable hydatique est formé de débris de scolex morts
- E. La souffrance du kyste se traduit par la formation de vésicules filles

Quelles sont les caractéristiques d'une HMG en cas de kyste hydatique centrohépatique

- A. Elle est régulière
- B. A surface lisse
- C. A surface nodulaire
- D. A bord antérieur mousse
- E. S'accompagne d'une splénomégalie

En cas d'infection d'un kyste hydatique du foie

- A. On peut observer un NHA sous phrénique droit à L'ASP de face
- B. Il peut s'agir d'un kyste type I
- C. Il peut s'agir d'un kyste type III
- D. La fissuration dans les voies biliaires est constante
- E. Le traitement ATB peut juguler l'infection

Dans le kyste hydatique infecté

- A. On peut observer un NHA sous phrénique droit à la Rx ASP debout de face
- B. Il peut s'agir d'un KHF type I échographique
- C. Il peut s'agir d'un KHF type III échographique
- D. La fissuration dans les voies biliaires est constante
- E. Le traitement antibiotique peut suffire à juguler l'infection

La rupture d'un KHF dans le péritoine : A. Est

- toujours provoqué par un traumatisme*
- B. Elle peut entraîner un tableau abdominal aigu
- C. Elle peut entraîner une mort immédiate
- D. Elle peut être à l'origine d'une hydatidose péritonéale secondaire
- E. Elle peut être asymptomatique

Le KHF ouvert dans le thorax

- A. Est l'apanage des kystes hydatiques des segments V et VI
- B. Est rarement infecté
- C. Est l'apanage des kystes hydatiques du dôme
- D. Son traitement est difficile
- E. Le scanner permet de confirmer le diagnostic et dresser le bilan lésionnel.

Un kyste hydatique du segment V du foie peut se rompre au niveau : A.

- De la plèvre.*
- B. Des voies biliaires.
- C. De la vésicule biliaire.
- D. Du péritoine.

E.Des veines sus hépatiques.

Une femme âgée de 52 ans, sans antécédents pathologiques, s'est présentée aux urgences pour des douleurs de l'hypochondre droit avec frissons. A l'examen clinique on note :

- température 38.5°C, TA : 140/80 mmHg, pouls : 80 battements/mn. - subictère conjonctival

- douleurs à la palpation de l'hypochondre droit sans masse palpable. Le bilan biologique a montré :

Globules blancs : 15000 éléments/mm³, hémoglobine : 12.5g/100ml, urée sanguine : 5.2mmol/l, glycémie 4.8mmol/l, créatinine sanguine 120mmol/l, Na⁺ + 138meq/l, K⁺ 3.8meq/l, TP80%, phosphatases alcalines : 390UI, SGOT : 25UI, SGPT : 25UI, bilirubine conjuguée 20 micromoles/l, bilirubine totale 50 micromoles/l.

L'échographie abdominale a montré une formation kystique multi vésiculaire du dôme hépatique de 10 centimètres évoquant un kyste hydatique du foie. La voie biliaire principale est dilatée. Le pancréas est d'aspect normal.

1) Dans quels segments du foie siège le kyste décrit à l'échographie.

.....
.....
.....

2) D'après les données du texte, quels sont les éléments cliniques et para cliniques en faveur d'une complication de ce kyste.

.....
.....
.....
.....
.....

- 3) Quelles sont les deux complications du kyste hydatique, présentées par cette malade ?

.....
.....

- 4) la patiente a été opérée, citer les principes du traitement chirurgical :

- 5) les suites opératoires ont été marquées par l'issue de bile à travers la sonde de drainage qui a été placée en sous hépatique (au cours de l'intervention), quelle est le nom de cette complication ?